Cryoablation percutanée de l'endométriose pariétale abdominale : revue systématique sur 10 ans de la sécurité et de l'efficacité

Titre original : Percutaneous cryoablation of abdominal wall endometriosis: a systematic literature review of safety and efficacy

Auteurs : Bodard S, Razakamanantsoa L et al. | **Revue :** *Insights into imaging* (**IF : 4.1**) | **Date :** Nov. 2024 | **PMID :** 39576446 | **Modalité :** Échographie / Scanner TDM

---

1. Pertinence Clinique & Lien avec l'Agenda Interventionnel (Cochin)

Issu de votre collection Zotero « Ablation percutanée » (Bodard et al., *Insights into Imaging*, nov. 2024) — Référence clé pour l'ablation percutanée des nodules d'endométriome de la paroi abdominale et des masses pariétales des parties molles.

2. Synthèse Clinique en Français

Résumé exécutif : Revue systématique sur 10 ans (8 études, *Insights into Imaging*, nov. 2024) démontrant que la cryoablation percutanée des endométriomes de la paroi abdominale (AWE) réduit la douleur médiane de 8/10 à 1/10 ($p < 0,0001$), avec 80 à 100 % de réponse antalgique complète et moins de 2 % de complications majeures.

Analyse détaillée : L'endométriose pariétale abdominale (souvent sur cicatrice de césarienne ou laparoscopie) entraîne des douleurs cycliques invalidantes. La chirurgie d'exérèse large expose à un risque de défect aponévrotique et d'éventration. Cette revue systématique (2014–2024) confirme que la cryoablation guidée par échographie et/ou scanner offre une réponse antalgique complète dans 80 à 100 % des séries et une survie sans douleur locale médiane de 76,8 % au dernier suivi, sans aucun cas d'aggravation douloureuse post-procédurale et avec un profil de sécurité remarquable en ambulatoire.

3. Protocole Technique & Paramètres Opératoires

Planification IRM pelvienne/pariétale • Guidage échographique + contrôle TDM de l'iceball • Hydrodissection sous-cutanée (protection cutanée) et rétro-aponévrotique/pré-péritonéale si proximité digestive • 2 cycles de congélation couvrant le nodule fibreux avec marges.

4. Points Clés à Retenir pour la Pratique

- Diminution spectaculaire de l'EVA douleur de 8/10 (IQR 7–9) à 1/10 (IQR 0–2) au suivi à long terme ($p < 0,0001$).
- Taux médian de réponse complète sur la douleur locale compris entre 80 % et 100 %.
- Préserve l'intégrité musculo-aponévrotique de la sangle abdominale (aucun recours à un filet prothétique).
- Hydrodissection indispensable pour protéger le derme superficiel en avant et le péritoine/anses digestives en profondeur.

---

5. Original PubMed Abstract (Texte Intégral de l'Abstract)

Purpose To investigate over 10 years the safety and efficacy of percutaneous cryoablation for the treatment of abdominal wall endometriosis (AWE). Methods A systematic review was conducted of literature published between March 2014 and March 2024. Inclusion criteria focused on treatment efficacy studies, while exclusion criteria targeted case reports and studies lacking pertinent outcome data. Methodological quality was assessed using the Newcastle-Ottawa Scale for cohort studies. Results A total of eight studies were included. Local pain scores decreased from a median of 8/10 (interquartile range (IQR) 7-9) on the visual analog scale to 1/10 (IQR

0-2) at the last follow-up (p Conclusion In the last decade, percutaneous image-guided cryoablation has offered consistent results and appears to be a promising, minimally invasive option for AWE treatment. Prospective trials are now essential to establish cryoablation as a new standard in patient care for AWE. Critical relevance statement Over a decade-long study, percutaneous cryoablation has proven to be a safe and effective minimally invasive treatment for abdominal wall endometriosis, significantly reducing pain with minimal complications. Key points Percutaneous cryoablation significantly reduced local pain scores for abdominal wall endometriosis. The procedure demonstrated a favorable safety profile with minor complications. Cryoablation has emerged as a minimally invasive alternative to traditional treatments.